議事メモ ー 戦略会議

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

議事メモ

会議情報

項目	内容
日時	2026/03/30（月）12:45～
会議名	3病院合同病院運営戦略会議（2025年度2月実績報告）
参加者	3病院の事務部長・経営企画・医事課ほか（※入力情報から個別参加者の特定不可）
記録者	経営企画部（スキルによる再構成）
配布先	戦略会議参加者、各診療科長、看護部長

大論点（BIG QUESTION）

2025年度の実績を「予算未達」と評価すべきか「前年度比改善」と評価すべきか？
令和8年度の診療報酬改定を見据えて、来年度はどこに経営資源を集中させるべきか？

論点別ディスカッションサマリー

論点1: 基本金組入前△13.8億円の収支をどう受け止めるべきか？

事前仮説：
予算比△51.9%であり厳しい数字。ただし退職金5億円の一時要因がある（推定：会議前の資料配布時点で、事務方は「退職金を除けば前年並み」との認識を共有していた可能性）

議論の要旨：
- △13億7,600万円（予算比△51.9%）の厳しい数字が報告された
- 一方で「3月に約5億円の退職金が出たが、令和6年度と比較して悪い数値ではない」との説明があった
- 4月からの診療報酬改定の影響を注視する方針が確認された

空気感：
△13.8億円という絶対額は重いが、「前年度と比較して悪くない」という発言が出ている点から、深刻だが想定内というトーンと推測される。退職金5億円を一時要因として切り分ける認識が共有されており、経常的な収支改善（粗利益+122.4%）に対する手応えがある空気感。（※入力情報が要約のため、発言者の温度感は推定）

仮説の進化：
- Before: 予算未達△51.9%は深刻な経営悪化
- After:
退職金5億円の一時要因を除けば経常収支は改善傾向。前年度対比では粗利益が2倍以上（55,297→122,991千円）。「予算の設定が高すぎた」問題と「実質的な改善」を分離して評価すべき

・変化のポイント: 退職金の一時要因切り分けと、前年度対比データの提示

ステータス： 決着（退職金除きでは前年度改善。来年度予算策定で再検討）

論点2: 診療報酬改定で約3億円の増収見込みは、現在の予算ギャップを埋められるか？

事前仮説：
（議論の流れから推定）事務方は改定のシミュレーションを事前に行い、ポジティブな見込みを持って会議に臨んでいた

議論の要旨：
・DPC係数1.6055で+1億7,300万円の増収見込みが報告された
・物価高騰対策+7,800万円、特定医療費加算+約2,000万円、外科評価項目+約2,800万円
・合計約2億9,900万円の増収見込み

空気感：
約3億円の増収見込みは明確なポジティブ材料として報告されたと推測される。現在の予算未達3.2億円とほぼ同額であり、「改定だけで帳尻が合う」という期待感が漂った可能性がある。ただし、これは現在の診療実績が維持される前提であり、外来患者数の減少（△8.5%）が続けば改定効果を食い潰すリスクがある。（※この懸念が会議中に議論されたかは入力情報から不明）

仮説の進化：
・Before: 改定の影響は読み切れない
・After:
DPC係数改定だけで+1.73億円。合計約3億円の増収が見込め、予算未達3.2億円をほぼ相殺できる。ただし増収を「改善の原資」ではなく「現状維持の原資」と見るべきリスクがある
・変化のポイント: 具体的なシミュレーション数値が提示されたことで、定量的な見通しが立った

ステータス： 要追加検討（4月の正式係数通知後に影響を精査する必要あり）

論点3: 外来患者数の減少（△8.5%）を食い止められるのか？

事前仮説：
（推定）外来患者数の減少は2年連続の構造的課題であり、会議前の資料で累計△1,810名のデータは認識されていた

議論の要旨：
・外来延患者数19,467名、初診率7.3%（目標10.0%に大幅未達）が報告された
・一方、外来単価24,001円は前年比+8.1%と改善。注射薬（化学療法）の増加が主因
・紹介率87.1%（前年比+3.3pt）だが、紹介件数自体は減少トレンド
・紹介受入拒否はベッド満床が主な理由と報告された

空気感：
外来患者減は既知の課題として淡々と報告された印象。「注射薬の増加が増収要因」という補足が入っていることから、量（患者数）の減少を質（単価）の向上で補っているという"良い面"を見せたい意図が感じられる。ただし、患者数減少の根本原因（紹介件数の構造的減少、特に整形外科△543件）に対する具体的な打ち手が会議中に議論されたかは不明。（※入力情報から空気感を十分に推定できず）

仮説の進化：
・Before: 外来患者数の減少は予算未達の主因であり対策が必要
・After:
患者数は減少が続くが、化学療法を中心とした単価向上により外来収入自体は前年比+2.4%の増収。「患者数回復」だけでなく「診療科ポートフォリオの質的転換」で対応する選択肢が浮上。ただしベッド満床による紹介拒否→紹介減の悪循環は未解消
・変化のポイント: 単価+11.6%上昇のファクトが、「量の回復」だけが解ではないことを示した

ステータス： 未決（来年度の具体的な対策は今後の検討事項）

論点4: 心臓血管外科の減少は構造的なものか、一時的なものか？

事前仮説：
（推定）資料1-2で入院収入△1,461万円/月が判明しており、報告者は減少傾向を問題視していた

議論の要旨：
・会議で「心臓血管外科が減少傾向」と明示的に報告された
・手術△520,200点、手術材料△406,085点、処置△171,196点と全面的な減少（資料1-2）
・年度合計258件（前年271件、△13件）で手術件数も減少（資料3）

空気感：
会議で名指しで報告されていることから、経営陣の注目度が高い議題と推測される。手術件数の減少だけでなく入院収入△1,461万円/月（年間換算△1.8億円）という影響の大きさが背景にある。（※具体的な原因分析や対策についての議論内容は入力情報から不明）

仮説の進化：
・Before: 心臓血管外科は安定した収益源
・After:
手術件数減（△13件/年）と手術材料の大幅減（△406,085点/月）は、高額デバイスを使う開心術の症例減を示唆。経カテーテル治療へのシフト（TAVI等）や、近隣の高度心臓外科施設との競合が構造的な要因の可能性
・変化のポイント: 「減少傾向」という事実が会議で共有されたことで、来年度の重点課題として認識された

ステータス： 未決（原因分析と対策立案が必要）

論点5: ダヴィンチ手術の年間200件目標は実現可能か？

事前仮説：
（推定）現状の年間122件（月10.2件）から200件への引き上げは意欲的な目標として提示された。目標10件/月は達成済みであり、次のステップとしての200件目標

議論の要旨：
・「ロボット手術（ダヴィンチ）：年間200件を目指す」方針が確認された
・現状は累計112件（月平均10.2件）で、現行の月10件目標は達成済み

空気感：
200件という数字が「目指す」方針として報告されていることから、目標としての方向性は合意されているが、具体的なロードマップはまだない段階と推測される。現状122件→200件は+64%の増加であり、実現にはかなりのハードルがある。会議で実現可能性への懸念が出たかは不明。

仮説の進化：
・Before: ダヴィンチは月10件の目標を達成しており順調
・After:
月10件は達成だが、年200件（月16.7件）は現状の1.6倍。泌尿器科（429件/年）と外科（976件/年）の適応拡大、手術室枠の確保、術者育成が同時に必要。「目標を出すこと」と「達成できること」のギャップの認識が必要
・変化のポイント: 200件目標の提示自体が新しい情報

ステータス： 要追加検討（ロードマップの策定が必要）

論点6: 稼働率94%の「満床」状態で紹介拒否をどう解消するか？

事前仮説：
（推定）2月の稼働率94.0%は好材料として報告される一方、紹介拒否（ベッド満床7件）との矛盾は認識されていた

議論の要旨：
・病床稼働率94.0%（今年度最高）が報告された
・同時に紹介受入拒否の主な理由が「ベッド満床」であることが報告された
・3月は稼働率92%、在院日数9.2日と予想

空気感：
稼働率94%は明らかにポジティブな数字として報告されている。一方で「ベッド満床で拒否」はネガティブな要因。この2つが同じ会議で報告されていることから、矛盾の認識はあるが、具体的な解決策の議論には至っていない印象。（※入力情報からは議論の深さを判断できず）

仮説の進化：
・Before: 稼働率を上げることが最重要
・After:
稼働率の「全体平均」と「病棟別偏在」を分けて管理する必要がある。整形外科で拒否3件が発生しているのは、特定病棟の満床であり全体の問題ではない。病棟横断的なベッドコントロールが真の解決策
・変化のポイント: 稼働率94%と紹介拒否7件が同時に報告されたことで矛盾が顕在化

ステータス： 未決（ベッドコントロールの仕組み検討が必要）

【未議論の論点】

本来議論すべきだったが触れられなかった（または入力情報に含まれなかった）論点：

・整形外科の紹介件数△543件（全科最大の減少）に対する具体的な回復策は？ —
心臓血管外科の減少は言及されたが、収益インパクトが最大の整形外科（外来+入院合算△2,492万円/月）への言及が見当たらない
・来年度予算の外来患者数前提を見直すべきか？ — 2年連続で予算未達だが、予算前提の修正についての議論は確認できない
・化学療法室の体制拡充は必要か？ — 化学療法が増収の主因として報告されているが、体制面の議論は確認できない
・人件費の部門別分析は行われているか？ — 2月単月+7.6%の増加について、退職金以外の要因分析の言及がない
・査定率0.54%（目標0.40%）の改善策の進捗は？ — 年間7,435万円の査定額に対する対策状況の報告が見当たらない

合意事項・意思決定

2025年度の収支は退職金一時要因を含めて「前年度並み」との認識を共有【空気感：大きな異論なく受容された模様】
4月からの診療報酬改定の影響を注視する方針【合意。約3億円の増収シミュレーションが提示済み】
ダヴィンチ手術の年間200件目標を方針として確認【空気感：方向性としての合意。具体的なロードマップはこれから】
3月の稼働率92%・在院日数9.2日の見通し【報告事項として共有】

ネクスト論点

次の会議・検討で解くべき「問い」：

診療報酬改定の増収+3億円を、外来患者減の穴埋めに使うのか、新たな投資に使うのか？
・背景: 改定増収（+3億円）≒ 予算未達（△3.2億円）であり、改定効果は「改善の余力」ではなく「現状維持の原資」に消える可能性
・仮説: 外来患者数の回復なくして改定効果を投資に回す余裕はない。外来対策と改定対応を同時並行で進めるべき

整形外科の紹介△543件は「回復可能な一時的減少」か「構造的な流出」か？
・背景: 全科最大の減収（△2,492万円/月）だが、会議で具体的な対策議論が見当たらない
・仮説:
ベッド満床による拒否→信頼低下→紹介減の悪循環が起きている。紹介元27施設への個別訪問で回復可能な部分と、近隣開業医の高齢化等による構造的減少を切り分ける必要がある

心臓血管外科の縮小は「経カテーテル治療へのシフト」として許容すべきか、「開心術の症例獲得」で巻き返すべきか？
・背景: 手術△520,200点/月、入院収入△1,461万円/月。会議で「減少傾向」と報告された
・仮説:
TAVIやステントグラフトへの移行はトレンドであり、開心術の単純な回復は困難。カテーテル治療の体制強化で「高単価×低侵襲」のポートフォリオへ転換すべきではないか

ダヴィンチ200件を達成するために、どの術式を、どの診療科で、いつまでに拡大するか？
・背景: 現状122件→200件は+64%。手術室枠・術者・適応の3要素すべてに対応が必要
・仮説:
泌尿器科の前立腺全摘・腎部分切除と、外科の直腸切除・胃切除が拡大候補。月4件（年48件）ずつ各科で増やせれば到達するが、手術室枠の確保がボトルネック

来年度予算の外来患者数前提は「予算ベース（910人/日）」を維持すべきか、「実績ベース（852人/日）」に修正すべきか？
・背景: 2年連続で外来患者数が予算を大幅に下回り（△6.2%）、達成不可能な予算が組織のモチベーションを下げるリスク
・仮説:
実績ベース（852人）+改善目標（+5%=895人程度）が現実的。ただし予算を下げれば収入見込みも下がるため、単価向上策とセットで議論すべき

ネクストステップ（TASK）

#	TASK	担当	期限	紐づく論点
1	診療報酬改定の算定要件確認と4月レセプト重点チェック体制の構築	医事課	4月第1週	論点1
2	整形外科の紹介減少27施設への個別訪問計画の策定	地域連携室・整形外科	4月中	論点2
3	心臓血管外科の症例減の原因分析（紹介減 or 適応変化 or 競合）	心臓血管外科・経営企画	4月中	論点3
4	ダヴィンチ200件達成のロードマップ素案（術式別・四半期別）	泌尿器科・外科・手術室	5月戦略会議	論点4
5	来年度予算の外来患者数前提のシナリオ分析（予算ベース vs 実績ベース）	経営企画	予算策定時期	論点5
6	病棟横断ベッドコントロールの仕組み検討	看護部・ベッドコントロール担当	4月中	論点2・6
7	DPC係数1.6055の正式通知確認と増収効果の精査	医事課・経営企画	4月通知後即時	論点1

空気感メモ

年度末の実績報告会議であり、全体的には「厳しいが想定内。来年度に期待」というトーン。基本金組入前△13.8億円の数字は重いが、退職金5億円の一時要因と前年度比の改善（粗利益+122.4%）が救いとなり、悲観一色にはなっていない。

診療報酬改定の+3億円シミュレーションは明確なポジティブ材料として受け止められた模様。ダヴィンチ200件目標も前向きな方針として共有された。

一方で、心臓血管外科の減少傾向が会議で名指しされたことは、経営陣の危機感の表れ。整形外科の紹介△543件については会議での言及が確認できず、最大の収益課題が十分に議論されていない可能性がある。次回会議では整形外科問題を正面から取り上げるべき。

外来患者数の減少は2年連続の構造的課題だが、化学療法の成長による単価上昇が「時間を稼いでいる」状態であり、この猶予期間のうちに紹介回復策を具体化しなければ、改定増収すら食い潰すリスクがある。

（※本議事メモは会議の要約メモから再構成したものであり、個別の発言者や発言の温度感は推定を含みます）